

Podłoże zaburzenia panicznego

Cztery czynniki: biologia, geny, środowisko, poznanie. To nie „słabość charakteru” ani „atak nerwów” — to zaburzenie z konkretnymi mechanizmami.

CZAS: 15 min czytania Po pierwszych sesjach

ŹRÓDŁO: Klein (1993); Hettema (2001); Clark (1986); Roy-Byrne (2006)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj uważnie cztery filary podłoża zaburzenia. Na końcu zaznacz, które czynniki *u Ciebie* grają rolę (część może być nieznana — to OK). Wracaj do karty, gdy pojawia się myśl „coś jest ze mną nie tak” — ona przypomni, że to **konkretny mechanizm**, nie tajemnicza wada.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Roy-Byrne (2006) i Craske (2014) traktują zaburzenie paniczne jako stan z biologicznymi i poznawczymi mechanizmami, nie „atak nerwów”. Pacjenci bez psychoedukacji wielokrotnie chodzą na izbę przyjęć, robią EKG i MRI, otoczenie minimalizuje („to tylko nerwy”). Po kilku atakach rozwija się wtórna agorafobia. Zrozumienie podłoża **obala mīt medycznego zagrożenia** — to warunek startu skutecznej terapii. Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej Barlowa wynosi 70-80% (Barlow 2007).

01 📋 Cztery filary podłoża — model biopsychospołeczny

1 · BIOLOGIA — FAŁSZYWY ALARM

Klein (1993): hipoteza *fałszywego alarmu uduszenia* (ang. *false suffocation alarm*) — nadwrażliwy system wykrywania CO₂. Test wziewny CO₂ wyzwała atak u **60-70%** osób z zaburzeniem panicznym vs ~5% kontroli. Lokus coeruleus (struktura pnia mózgu): nadaktywność, uwalnianie noradrenaliny.

2 · GENY — DZIEDZICZNOŚĆ ~40%

Hettema i wsp. (2001, meta-analiza): dziedziczność zaburzenia panicznego ~**40%**. Krewni 1. stopnia mają 4-8× wyższe ryzyko. Geny: COMT (dopamina), 5-HTT (serotonina), receptor adenyzy A2A — dlatego kawa wyzwała ataki.

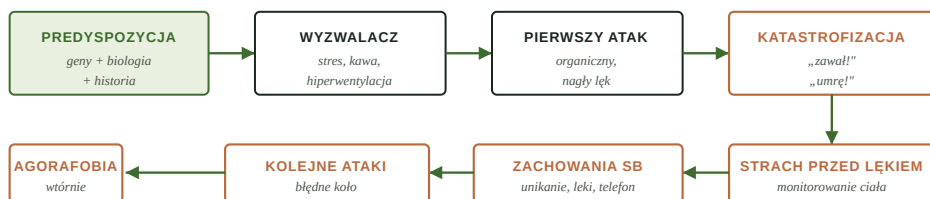
3 · ŚRODOWISKO — WYZWALACZE

Początek najczęściej 18-35 r.ż. (szczyt 25-30). Czynniki ryzyka: separacja w dzieciństwie (śmierć rodzica, rozwód), traumy, nadużywanie substancji (marihuana często wyzwała pierwszy atak), choroby somatyczne (tarczyca, kardiologia), ostry stres.

4 · POZNANIE — MODEL CLARKA

Clark (1986): centralny mechanizm to **katastroficzna interpretacja** odczuć cielesnych. Po pierwszym ataku rozwija się **wrażliwość lękowa** (ang. *anxiety sensitivity*; Reiss 1985): „strach przed lękiem”. Każde wzmożone odczucie traktowane jako zwiastun katastrofy.

02 🔄 Jak powstaje zaburzenie — sekwencja od predyspozycji do agorafobii



Najważniejszy wniosek: sam pierwszy atak to zwykle reakcja organiczna. To *katastroficzna interpretacja* zamienia jednorazowy incydent w zaburzenie. Terapia uderza w to ogniwo — i cała kaskada się rozpada.

03 Teoria A vs Teoria B — dwie narracje, dwie ścieżki

	TEORIA A — MEDYCZNA KATASTROFA	TEORIA B — FAŁSZYWY ALARM
Co się dzieje?	„Mam zawał / udar / umieram.”	„Mam nadwrażliwy alarm fizjologiczny.”
Co robić?	Iść na izbę przyjęć, kolejne EKG, MRI, unikać sytuacji.	Psychoedukacja, dziennik, ekspozycja interoceptywna.
Wynik po 6 mies.	Agorafobia, wtórna depresja, koszty medyczne, brak ulgi.	Remisja u 70–80% (Barlow 2007). Wraca normalne życie.

Teoria B nie znaczy „to nic poważnego”. Znaczy: **to coś poważnego z konkretnymi mechanizmami i konkretnym leczeniem** — w przeciwieństwie do Teorii A, która prowadzi w ślepy zaułek.

04 Moje czynniki — co u mnie gra rolę?

Część odpowiedzi może być nieznana — to OK. Nie diagnozuj się sam/-a, zapytaj terapeuty, gdy chcesz coś rozwinąć.

BIOLOGIA / ZDROWIE

— tarczycy, kardiologia, leki, kawa, marihuana?

GENY / RODZINA

— ataki paniki, lęk, depresja w bliskiej rodzinie?

ŚRODOWISKO

— co działo się przed pierwszym atakiem? stres, strata, choroba?

MOJA KATASTROFICZNA INTERPRETACJA

— „boję się, że...” — dosłownie

Klucz: najsilniejszy komunikat psychoedukacyjny: „*masz nadwrażliwy alarm fizjologiczny + dziedziczną predyspozycję ~40% + wyuczoną katastroficzną interpretację. Atak paniki jest nieprzyjemny, ale **całkowicie bezpieczny** — to Twój mózg myli się w interpretacji*”. Roy-Byrne (2006): zaburzenie paniczne ma najczystszy mechanizm spośród wszystkich zaburzeń lękowych — i właśnie dlatego najlepiej reaguje na ukierunkowaną terapię.